

智能纪要：当日入院当日手术项目复盘 2026年3月20日

录音主题：当日入院当日手术项目复盘

录音时间：2026年3月20日（周五） 16:06 - 16:53（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

当日入院当日手术项目复盘与经验分享

 **核心观点：**

- 项目价值显著：通过“三准入六前移”模式，有效缩短术前等待，提升资源利用与患者体验，测算相当于新增600余床位。
- 信息化支撑是关键堵点：当前术前检查医嘱系统与医院CASE系统独立，需人工维护，成为规模化推广的主要瓶颈，亟待技术打通实现自动同步。
- 创新项目依赖多部门协同：从试点到推广需深入临床、联合医务、医保、信息等多部门形成合力，弱化边界，共同推进。

项目背景与模式

 **项目启动背景**

- 医院 **手术间资源** 增长大于床位资源
- 外科患者等候时间长，**平均住院日** 较长
- 存在患者入院后 **未手术** 的资源浪费
- 需摆脱 **床位依赖**，优化病种结构
- 提升 **手术患者占比** 与患者满意度

 **核心模式：三准入六前移**

- 三准入**：从病种、病人、特殊情况筛选
- 六前移**：术前检查、评估、文书、麻醉评估等
- 目标：门诊完成检查评估，**入院即可手术**
- 整合 **院前评估中心**，全面覆盖外科科室
- 增加 **手术计划性**，减少患者无效住院

 **预期效果测算**

- 50岁以下** 患者80%进入当日手术模式
- 50-70岁** 患者80%进入次日手术模式
- 不增床位下，相当于增加 **600多张床**
- 提升 **手术占比**，优化排程后未手术占比

项目推进历程与成效

24年3月

项目启动与首次测试

普外科全人工流程测试，暴露门诊资源预约慢等问题

24年9月

外出学习与二次试点

赴瑞金、浙一等医院学习，胸外科试点流程优化

25年3月

政策落实与全面宣讲

落实医保并账政策，向所有外科科室宣讲

26年2月

重启试点建立SOP

骨科试点，建立标准化流程，多部门协同更紧密

成效维度	具体措施	阶段成果
系统支持	打上“当日手术”标签，开发患者管理模块	集中管理患者状态，线上查询与提示
流程优化	运用住院资源预约检查，报告时效性高	检查尽量约在同一天，减少患者来院次数
医保并账	科室梳理术式与对应检查，医务医保审核	必做与条件必做检查可并入住院费用
数据表现	胸外、骨科等科室运用该模式	胸外科术前等待时间缩短近一天

飞书智能会议纪要 AI 生成

音频围绕医院当日入院、当日手术项目展开，分享了项目背景、推进情况、阶段性成效及工作思考，探讨了系统优化等问题，强调创新工作需多部门协同，遵循科学工作方法，内容如下：

- 项目背景与需求
 - 问题导向
 - 资源紧缺：医院手术间数量增加，但床位资源相对不足，未来手术间数量将大于床位资源，需摆脱床位依赖，优化病种结构。
 - 效率提升：医院相对同级别其他医院，平均住院日较长，效率有提升空间，目前未建立系统有效的术前病人管理机制，资源浪费严重。
 - 患者需求：等候住院的患者中大部分为外科患者，等候时间长，需提高手术患者占比，提升患者满意度。

- **需求分析：**项目基于临床和管理问题，以及患者、医护人员和学生的需求而开展，旨在解决资源紧缺、效率低下和资源浪费等问题。

● **项目模式与流程**

- **模式核心：**当日入院、当日手术模式的核心是三个准入和六个前移。三个准入考虑病种和病人因素，筛选适合该模式的患者；六个前移包括术前检查、评估、文书、麻醉评估和手术申请的前移。
- **流程介绍：**从门诊开入院证开始，患者成为待入院目标患者，经过术前检查、评估和麻醉评估后进入待手术患者库，根据手术日通知入院，入院即可手术，可及时替换因患者原因停台的情况。
- **流程迭代：**项目流程经过多次迭代，从最初的理想状态到逐步细化，2024 年 3 月启动后，经过多次修改和调整，2026 年 1 月在多部门参与下进一步细化。

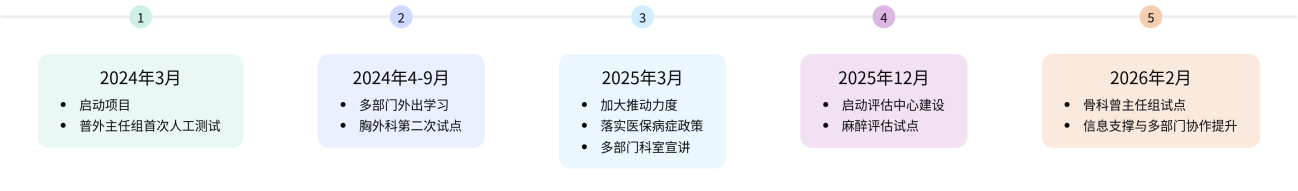
● **项目推进情况**

◦ **测试与试点**

- **首次测试：**2024 年三四月份在普外主任组进行测试，人工干预流程多，患者往返次数多，门诊资源检查时间长，医保病症存在问题。
- **学习与试点：**2024 年组织多部门到瑞金、中山、浙一、浙二院学习，9 月份在胸外科进行第二次试点，相对顺畅但仍暴露问题。
- **后续推进：**2025 年 3 月加大推动力度，落实医保病症政策，多部门到外科室宣讲，12 月份启动评估中心建设，2026 年 2 月 25 日在骨科曾主任组进行试点，信息支撑和多部门合作更好。

◦ **阶段性成效**

- **系统优化：**为患者增加当日住院、当日手术标签，开发患者管理模块，打通与检查科室沟通，优化麻醉评估补开检查功能，结合共病门诊新增转供病通道，更新护理老师查看患者状态功能。
- **术前检查梳理：**重新梳理多个科室的术前检查和医保并账，区分必做和条件必做项目，但系统暂无法区分条件。
- **手术数据：**2025 年上半年大量科室参与流程，完成 60 多台手术，部分科室术前等待时间明显缩短。



项目历经两年多迭代，从人工测试逐步走向系统化、标准化推进

● **工作思考与挑战**

- **深入临床一线**：需深入临床一线，洞察实际需求，但各科室、亚专业和医疗组需求不同，需用一套系统平衡各方需求。
- **多部门协同**：医院重大专项需多部门协同，弱化边界，形成合力，各部门要有主人翁意识。
- **信息化支撑**：信息化支撑非常重要，如解决患者术前检查状态查询和医嘱库更新问题，需与信息部门合作打通系统自动升级功能。

● **后续工作计划**

- **重启试点**：重启当日手术全流程的试点，以建立当日住院、当日手术的标准化 SOP 标准流程。
- **系统优化**：与信息部门合作，打通术前检查医嘱系统与医院实际 case 医嘱系统的数据互通，实现系统自动升级和更新功能。
- **持续推进**：在全院更多科室推广当日入院、当日手术模式，增加病种，提升管理效率。

📌 智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 医院信息专项推广、实践及资源管理需求

本章节主要围绕信息专项推广展开。指出推专项基于发现的问题和需求，需先形成方案讨论，但要考虑能否落地。还分享了项目实践情况，如2018年曾通过术前检查前一夜模式缩短住院日，后因疫情停滞，24年新增手术间，结合医院资源变动及管理需求，需摆脱床位依赖，提升患者满意度。

04:33 医院外科候诊多、效率待提升，缺术前管理机制

本章节主要围绕医院现状展开。截至今年3月，医院等候住院的3.3万患者中70%是外科患者，80%等候时间长的也是外科患者，等候数量前十科室除心内科外都是手术科。医院资源紧缺、效率有提升空间，平均住院日较长。25年各手术科室收治大量未手术出院病人，且未建立有效术前病人管理机制，无法提前筛选手术患者。

05:45 当日入院当日手术模式介绍及效果测算

本章节围绕医院手术流程优化展开。为解决资源紧缺、浪费等问题，提出当日入院、当日手术模式，含三个准入和六个前移。该项目自2024年3月启动，流程经多次迭代细化。测算显示，此模式能提升效率、增加业务量，还可减少患者无效住院，且利于围术期医疗质量和安全。

11:31 项目启动后首次测试及后续试点情况汇报

本章节说话人2先介绍项目背景，接着汇报24年3月启动项目后做的事。4月用全人工跟进一例手术流程，人工干预多、患者往返次数多、检查时间长等问题凸显。之后多部门达成共识推动工作，针对流程和系统优化，还组织团队外出学习，9月在胸外科二次试点，虽有提升但仍存在问题。

15:45 两年项目推进关键节点及多部门协同工作情况

本章节介绍了项目历时两年的整体情况与关键节点。9月后节奏变缓，2月锦江开业，3月加大项目推动力度，与大外科讨论并由黄院长带队宣讲，到省医保局沟通落实术前检查病症政策，多部门到外科室宣讲。6月部分科室搬迁运用系统，12月启动评估中心建设，1月形成多部门专班推动工作。

18:35 2026年当日手术试点情况及问题总结

本章节提到2026年医院运营压力大，手术台次纳入临床科室目标责任书考核。推广至全院科室管理难度升级，急需建立当日住院、当日手术标准化SOP。重启当日手术全流程试点，2月25日在骨科曾主任组开展，完成四例试点工作。相比2024年，信息支撑更好、多部门合作更紧密，还记录各环节问题。

21:51 医疗系统推进成效、优化措施及通道新增情况

本章节介绍了目前取得的阶段性成效。一是为患者增加当日住院、当日手术标签，开发患者管理模块集中管理；二是与检查科室沟通，用住院资源预约术前检查，提高报告时效性；三是优化麻醉评估补开检查流程；四是结合医院推进共病门诊，新增转共病通道，更新护理老师查看患者状态的相关内容。

24:19 术前检查梳理、医保并账及阶段性手术成果

本章节介绍了三方面阶段性成效。一是落实术前检查梳理和医保并账，重新梳理多个愿开展科室，由科室发起、医务医保审核后上传系统，出院时并账，分必做和条件必做，但系统无法区分。二是2025年上半年有大量科室参与流程，完成60多台全流程标准手术。三是提到搬迁到天府的耳鼻喉及胸外科的三个医疗组。

25:35 项目推进成果、思考及系统需求平衡难题

本章节先提到骨科参与项目多，胸外术前等待时间缩短近一天。接着分享项目工作思考，强调要深入临床一线，与大外科、麻醉、医务等多部门沟通收集意见，助力项目推进。同时提出困惑，各科室、亚专业、医疗组需求不同甚至相悖，后续需思考如何用一套系统满足需求并保障流程运作。

27:37 24年起重大专项需多部门协同，26年强化合力

本章节说话人2表示，自24年3月至今两年多，医院重大专项工作涉及多方面，需多部门协同参与，否则难以推动和达成目标。26年1月形成专班后，加大了多部门协同力度，要弱化部门边界、形成合力，各部门需有主人翁观念，共同牵头完成相关项目。

28:17 术前检查信息化支撑案例及系统升级需求

本章节强调信息化支撑的重要性，举了两个例子：一是麻醉评估时，信息系统助力判断患者术前检查完成情况，提高效率；二是术前医嘱库存在不能随医嘱更新而更新的问题，目前靠人工维护。还指出术前检查医嘱系统与医院实际医嘱系统无数据互通，呼吁信息部门一起攻克难题，最后表达对项目支持的感谢。

33:37 创新工作不易，凝聚团队智慧汗水需珍惜

本章节说话人1表示工作要不了滑头，PPT经多次迭代和演练形成。他总结了三点，重点强调做创新工作不容易，自己日常有繁重常规工作，还需分析异常情况，若能挤出休息时间推动创新，是有情怀的表现，这凝聚着团队智慧和汗水，且创新随时变化迭代，项目可能随时没了，应且行且珍惜。

35:18 推进医院工作要保持正能量并多部门协同

本章节说话人1认为要初心不改，推进工作困难重重，如智慧运营平台、运营专项等工作推进中会遇到想象不到的问题，还会挨骂。当前最大矛盾是领导需求与现实工作推进的差距。应对时要保持平常心、积极正能量，寻求多部门帮助，如今单枪作战已不可行，需团队协作，分工牵头做事难以做好。

36:30 为医院创新工作应众人合力克服万难

本章节说话人1先是提及“为众人抱薪者，不可使其暴毙于风雪”，强调创新不易。指出不管是运管还是信息等部门，只要是为了医院，无论哪个牵头，每个人都应全力以赴、克服万难。相信后续不管结果如何，都会留下美好回忆和故事，最后表示分享内容若有不当请大家批评指正。

37:18 业务交流分享及PDCA工作思路学习

本章节是参会者分享感想。说话人3认为大人事团队与周部长总结的三方面心路历程相符，指出部门与运营部在照片整理上有差距，还强调运营部解决问题的步骤值得新闻部学习，即遵循PDCA思路。说话人1觉得这是交流分享场合可缓解压力，还分享了开会“三宝”及公文模板等实用信息。

43:48 信息支持不足问题及借助数据智能解决思路

本章节说话人3指出信息支持严重不足。一是大数据可助力术前信息判断，利用人工智能总结规则，推荐适合病种及术前检查，减轻人工沟通负担；二是主数据问题未受重视，信息工作可确保人员等数据在各系统间一致，建系统时应考虑数据相关性，今年应重点解决这些问题。

📌 智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[当日入院当日手术项目复盘](#)
- 文字记录
 - [当日入院当日手术项目复盘 2026年3月20日](#)